

MAIL KOPIE

Entnahme: 09.04.2024
Eingang: 10.04.2024 nz7/ob7
Ausgang: 12.04.2024 yxu/QF9
Original an: Dr. med. Aleksis N. Doert, Winterthur
Kopie an: Prof. Dr. med. Bruno Fuchs, Winterthur

Patient Haas David, geb. 25.11.1997

B2024.10435

Diagnose

CD34-positive Spindelzellneoplasie (siehe Kommentar).

Kommentar

Auffallend und wichtig im vorliegenden Fall ist die anamnestische Angabe, dass der Tumor bereits seit frühester Kindheit besteht. Rein morphologisch ("Lipofibromatose" Aspekt) liegt ein Tumor aus dem fibroblastären Formenkreis vor. Differentialdiagnostisch wurden initial auch ein sog. superfizieller CD34-positiver Spindelzelltumor und ein sog. "fibrous hamartoma of infancy" in Betracht gezogen. Allerdings spricht der abschliessende Immunphänotyp (CD34+/S100+/panTRK+) für einen **NTRK rearrangierten Spindelzelltumor**, eine molekular definierte Tumorentität, die definitiv neu in die WHO Klassifikation der Pädiatrischen Tumoren aufgenommen wurde (Kapitel Weichteiltumoren), während sie in der WHO Klassifikation der Weichteiltumoren noch als "emerging" im Kapitel der Tumoren mit unsicherer Differenzierung gelistet wurde. Angesichts der langen Anamnese und der extrem niedrigen Proliferationsrate ist von einer **benignen Tumorbilogie** auszugehen. Falls gewünscht, können wir eine molekularpathologische Sicherung der NTRK-Fusion in die Wege leiten.

Klinik

Unklare Weichteilschwellung am Dig. II medial, kutan sowie basal an der Sehne gelegen, Fuss rechts. Ausschluss Malignität.

Material

Stanzbiopsie Raumforderung Dig II Fuss rechts.

Makroskopie

Beige-bräunlicher Stanzzyylinder von 1,2 cm Länge.

Mikroskopie

Stanzbiopsie mit spindelzelliger Proliferation im Fettgewebe und mitinvolvierten Hautadnexen, insbesondere ekkriner Drüsen (Lipofibromatose ähnlich) . Fokal einzelne vergrösserte hyperchromatische

Dieses Dokument wird nicht handschriftlich unterzeichnet, sondern mittels elektronischer Signatur freigegeben.

Wir geben Ihnen gerne telefonisch Auskunft.
Veröffentlichung von Inhalten (pathologischen Befunden) nur nach Rücksprache mit dem Institut für Pathologie.

Zellkerne mit Pseudoinklusion, insgesamt aber homogene Chromatinstruktur. Keine Pleomorphie. Immunhistochemisch kräftige Expression von CD34, und schwache Koexpression für S100. Starke und homogene zytoplasmatische Positivität für panTRK. Sehr schwache Expression von Aktin. Negative Immunreaktion für Zytokeratine (AE1/3), Desmin, Beta-Catenin (nur zytoplasmatisch) und MUC-4. Proliferationsfraktion in einer Ki67 Färbung bei < 1%.

PD Dr. med. Peter Karl Bode, Chefarzt
052 266 25 01

Dr. med. Georgios Pantazis, Assistenzarzt
052 266 49 05

Dieses Dokument wird nicht handschriftlich unterzeichnet, sondern mittels elektronischer Signatur freigegeben.

Wir geben Ihnen gerne telefonisch Auskunft.
Veröffentlichung von Inhalten (pathologischen Befunden) nur nach Rücksprache mit dem Institut für Pathologie.